



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

4 בדצמבר 2023

1686

כ"א בכסלו התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 15) (מסירת מידע לשם זיהוי נפטר או קביעת סיבת מוות).

התשפ"ד-2023 254

הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 15) (מסירת מידע לשם זיהוי נפטר או קביעת סיבת מוות), התשפ"ד-2023

תיקון סעיף 20 1. בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996¹, בסעיף 20(א)(3), בסופו יבוא:

ד ב ר י ה ס ב ר

לא נקבעה סיבת המוות בטופס הודעת הפטירה, רשאי רופא לשכת הבריאות לקבוע את סיבת המוות לפי מיטב ידיעתו ואמונתו. מצבים שבהם לא נקבעה סיבת המוות בהודעת הפטירה על ידי רופא אח, הם למשל במקרה שבו הפטירה נקבעת על ידי פרמדיק או רופא בשטח (כאשר הפטירה לא מתרחשת בין כותלי בית חולים). קבלת המידע הרפואי לגבי המנוח מאפשרת לרופא בלשכת הבריאות המחוזית לקבוע את סיבת המוות, ככל שניתן, גם בהסתמך על המידע הרפואי שעשוי להיות רלוונטי לצורך קביעה זו, כגון קיומן של מחלות רקע, אשפוזים אחרונים, תרופות, רגישויות מיוחדות וכדומה.

מטרתו של תיקון זה, להבהיר ולעגן את הפרשנות המשפטית שלפיה פעולות אלה של זיהוי מדעי של נפטרים אלמונים ושל קביעת סיבת המוות של נפטרים, ייחשבו חלק מפעולות טיפול רפואי. פרשנות זו היא הבסיס להעברת מידע רפואי בהתאם לסעיף 20(א)(3) לחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996 (להלן – החוק), לרופאי המכון ולרופאים בלשכות הבריאות המחוזיות. מתן אפשרות להעברת המידע הרפואי באופן ישיר לרופאי המכון ולרופאי לשכות הבריאות, לצורך ביצוע תפקידם, חלף שימוש באמצעים אחרים הכוללים הסתייעות במשטרת ישראל והוצאת צווים שיפוטיים – מאפשר לייעל ולזרז את הליך זיהוי נפטרים אלמונים ואת הליך קביעת סיבת המוות ומאפשר את הבאתם לקבורה של נפטרים בהקדם האפשרי. העברת מידע רפואי לרופאי המכון ולרופאי לשכות הבריאות, לגבי נפטרים שנבדקים על ידם, חשובה בעיתות שגרה, וביתר שאת באירועי חירום כדוגמת אירועי השבעה באוקטובר, וכן באירועי חירום אחרים כגון אסונות אורחיים או אסונות טבע.

סעיף 1 ההוראות החלות במערכת הבריאות לעניין שמירה על זכויות המטופל בכלל, ועל עצמאותו, כבודו ופרטיותו בפרט, נקבעו בחוק, והן מאזנות בין זכויות בסיסיות מסוימות ובין אילוצים וצרכים שונים. זכות המטופל הקבועה בסעיף 5 לחוק, לקבל טיפול רפואי נאות מן הבחינה המקצועית, מחייבת את מערכת הבריאות, בין השאר, להציג למטופל מידע רפואי מלא ככל שניתן לגבי המטופל, בזמן הטיפול, לצורך הטיפול בו. הזכות להבטחת המשך טיפול נאות במעבר ממוסד רפואי אחד לאחר (סעיף 8 לחוק) אף היא יכולה להתממש באמצעות יצירת מנגנון המאפשר הצגת המידע למטופלים. מנגד, חלה חובה לשמור

כללי ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה שבמסגרתה חדרו מאות מחבלים ליישובים בדרום הארץ מהיבשה, מהאוויר ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים. במתקפת הטרור האכזרית רצחו המחבלים כ-1,400 אזרחים וחיילים, פצעו אלפים וחטפו מאות אזרחים לשטח רצועת עזה. כמו כן, עד ליום זה, ישנם אזרחים וחיילים המוגדרים כנעדרים. לנוכח האירועים החמורים, החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (הקבינט המדיני-ביטחוני) על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והוכרז בצה"ל על מבצע "חרבות ברזל". כמו כן, הוכרז על מצב מיוחד בעורף בהתאם לחוק ההתגוננות האזרחית, התש"א-1951, תחילה על ידי שר הביטחון – לגבי חלק משטח המדינה, ובהמשך על ידי הממשלה – לגבי שטחי מדינת ישראל כולה. נכון לעתה, ההכרזה בעניין מצב מיוחד בעורף בכל שטח המדינה, כפי שאושרה על-ידי ועדת החוץ והביטחון, עומדת בתוקף עד יום י"ז בכסלו התשפ"ד (30 בנובמבר 2023).

על העבודה הרגילה והמורכבת של זיהוי כללי המלחמה הרבים אמונים צה"ל ומשטרת ישראל, מכוח חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי), התשנ"ו-1996, בסיוע המרכז הלאומי לרפואה משפטית (להלן – המכון). הפועל תחת משרד הבריאות. תפקידיו של הצוות המקצועי במכון כוללים ביצוע בדיקות קליניות ופורנויות מסוגים שונים, המהוות חלק במיורור רפואי שמטרתו קביעת זהותם של נפטרים אלמונים באופן מדעי וגילוי סיבת המוות של נפטרים. לצורך מילוי תפקידים אלה נדרשות למומחי המכון רשומות רפואיות ממסודות רפואיים ושלעדיהן לא ניתן, על פי רוב, להתחיל בביצוע נתיחה שלאחר המוות או להשלים את הליך הזיהוי המדעי או את חוות הדעת בדבר סיבת המוות.

סעיף 8(1)(ב) לפקודת בריאות העם, 1940, קובע כי רופא לשכת בריאות מחוזית שבתחומה נפטר מנוח או שבו יובא לקבורה, רשאי לתת רישיון קבורה, ובסעיף 8(1)(ד) לפקודה האמורה נקבע כי לא יינתן רישיון קבורה כאמור אלא אם כן הוגשה ללשכת הבריאות המחוזית הודעה על פטירה על פי חוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965, שצוינה בה, בין השאר, סיבת המוות כפי שנקבעה על ידי רופא ואושרה בחתימתו. לפי אותו סעיף, במקרים שבהם

¹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 327; התשפ"ג, עמ' 727.

”לעניין זה, יראו כטיפול במטופל גם זיהוי גופה או חלק ממנה או קביעת סיבת מוות, על ידי מטפל שהוא רופא מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית או רופא לשכת בריאות מחוזית כמשמעותו בסעיף 8(א) לפקודת בריאות העם, 1940².”

ד ב ר י ה ס ב ר

הקובעים את סיבת המוות או את זהות הנפטר אינן שונות באופן מהותי מטיפול רפואי גרידא – מדובר בגורמים מטפלים (כהגדרת ”מטפל” בחוק), ובביצוע פעולות קליניות המשיקות ומקבילות לפעולות של טיפול רפואי באדם חי – בירור היסטוריה רפואית, קביעת אבחנה והסקת מסקנות. בחלק מהמקרים קביעת זהות הנפטר מתבצעת אל מול מידע רפואי ממהלך חייו של אדם, כגון צילומי רנטגן, ניתוחים שעבר, צילומי שיניים ובדיקות רפואיות שונות שביצע בחייו. הנגשת המידע הרפואי לגבי הנפטרים, לרופאים כאמור, תואמת את תכלית של שמירה על רצף טיפולי, והיא נדרשת לצורך קבלת ההחלטה המקצועית הנכונה ביותר בנוגע לזיהוי המנוח או לקביעת סיבת מותו. נוסף על כך, ואף על פי שסעיף 20(א)(3) אינו כפוף לקבלת הסכמת המטופל, ניתן להניח חזקת הסכמה של אדם לכך שהמידע הרפואי לגביו יימסר לגורם רפואי מתאים במטרה לזהות אותו לצורך הבאתו לקבורה או לקבוע את סיבת מותו, באופן שישלים את כלל מהלכי הטיפול הרפואי בו.

על פרטיות המטופל (סעיף 10 לחוק) ועל הסודיות הרפואית שלו (סעיף 19 לחוק).

סעיף 20 לחוק קובע שורה של חריגים לחובת שמירת הסודיות, שבהתקיימם מטפל או מוסד רפואי רשאים למסור מידע לגבי מטופל לגורם אחר. החריג המוסדר בסעיף קטן (א)(3) לסעיף האמור, קובע כי העברת המידע כאמור מותרת כאשר ”מסירת המידע הרפואי היא למטפל אחר לצורך טיפול במטופל”.

מוצע להבהיר בסיפה של הוראה זו, כי יראו כטיפול במטופל, לעניין הסעיף האמור, גם זיהוי של גופה או חלק ממנה, וקביעת סיבת מוות על ידי רופא מהמרכז הלאומי לרפואה משפטית, וכן על ידי רופא לשכת בריאות מחוזית.

אף על פי שהמונח ”טיפול רפואי” משמעו המובן מאליו הוא טיפול באדם חי ולא באדם מת, ההגדרה בחוק למונח זה אינה סגורה, והיא עשויה לכלול פעולות טיפול נוספות על אלה המנויות בה, אם הן עולות בקנה אחד עם תכליות החוק. הפעולות שנעשות על ידי הרופאים

² ע”ר 1940, תס’ 1, עמ’ 191.

